Boletín Epidemiológico N° 39 de 2024

Dirección de Vigilancia de la Salud

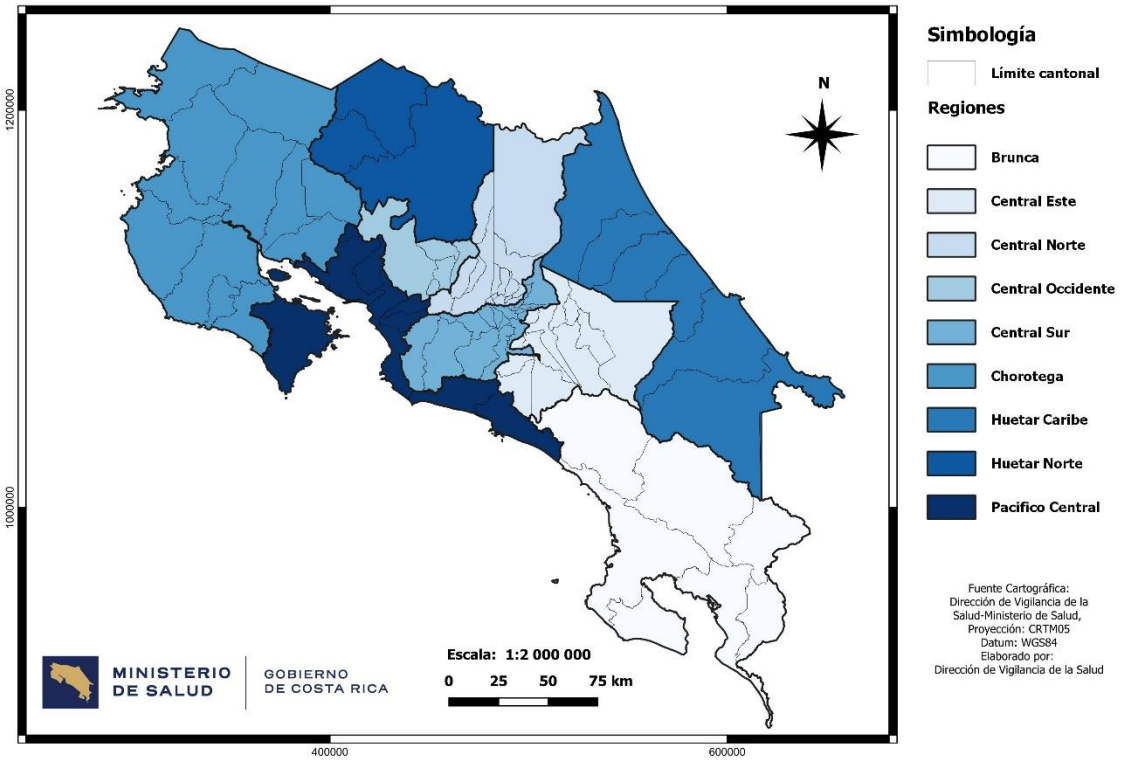
Ministerio de Salud

11 de octubre de 2024

Tabla de contenido

Arbovirosis **3**
Malaria **9**
Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 40 **18**
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19 ..... **19**
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) **35**
Miasis por Gusano Barrenador en Humanos **37**

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud

Adrián Montero Bonilla
Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Dengue

El 7 de octubre la OPS emitió una Alerta Epidemiológica por el aumento de casos de dengue en la Región de las Américas, el número de casos de dengue registrados durante el primer semestre del 2024 superó al número de casos reportado en un año, de todos los años anteriores registrados. Hasta la semana epidemiológica (SE) 36 del 2024, 47 países y territorios de la Región de las Américas han reportado 11.732.921 casos de dengue, una cifra dos veces y medio mayor al número de casos registrados durante todo el 2023 con 4.594.823 casos de dengue.

Tabla 1.
Dengue y dengue grave casos y muertes para subregiones de las Américas, 2024.

Región	Dengue	Dengue grave	Total	Muertes
América del Norte	1 942	37	1 979	0
Caribe Latino	13 622	290	13 912	13
Caribe No Latino	64 215	904	65 119	35
Cono Sur	10 544 910	9 181	10 554 091	5 978
Istmo Centroamericano y México	694 937	4 627	699 564	464
Subregión Andina	630 771	3 722	634 493	494
Las Américas	11 950 397	18 761	11 969 158	6 984

Fuente: Plataforma de información en salud de las Américas (PLISA) OPS

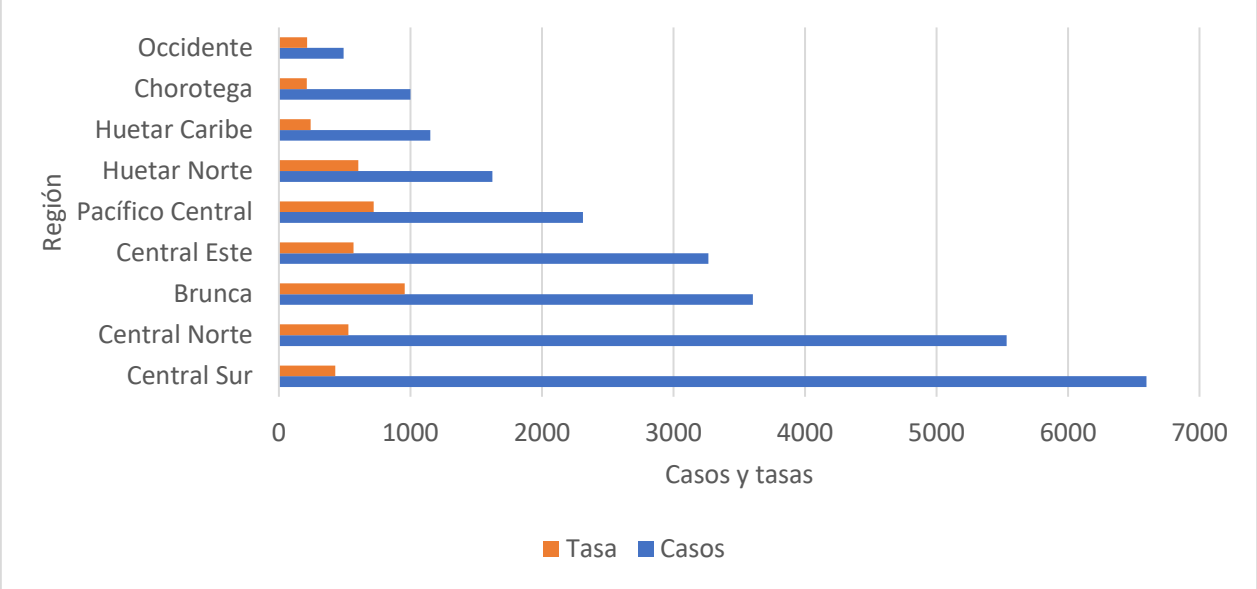
En Costa Rica a la semana epidemiológica 39 del año 2024 se han notificado **25581 casos** de dengue para un aumento con respecto a la semana 38 de **616 casos** de dengue, de estos **136 casos** han sido notificados como dengue con signos de alarma.
En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 6598 casos y la región con mayor tasa 955,6/100.000 habitantes en la Brunca.

Tabla 2.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 39, 2024 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Sur	6598	427,9
Central Norte	5533	528,8
Brunca	3604	955,6
Central Este	3267	568,2
Pacífico Central	2311	721,1
Huetar Norte	1623	604,1
Huetar Caribe	1152	240,5
Chorotega	1001	212,0
Occidente	492	215,0
Total	25581	481,8

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 1.
Costa Rica: casos de dengue y tasa por región a la semana epidemiológica 39, 2024.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

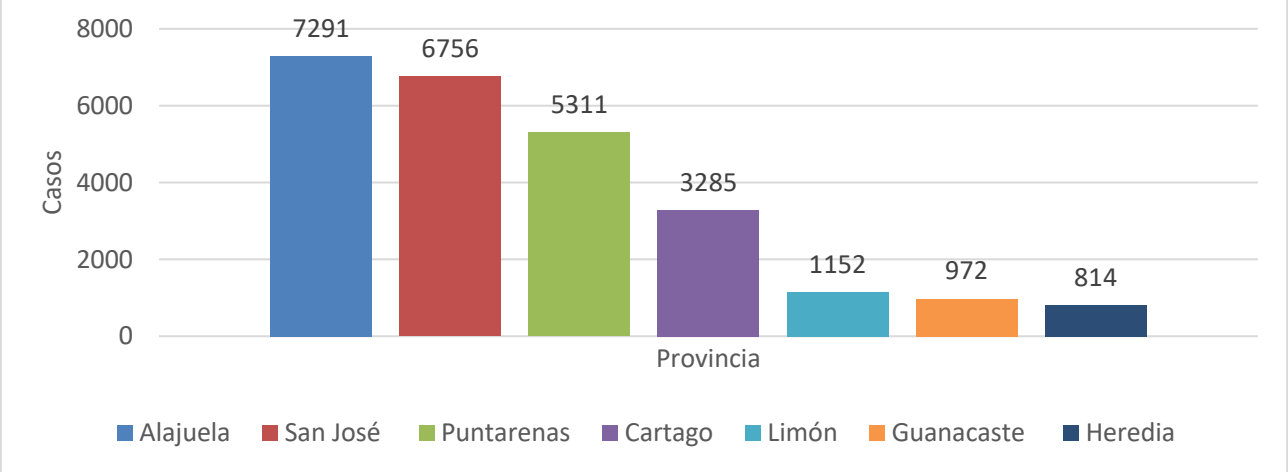
En la tabla 3 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2024, la provincia de San José presenta un aumento de **305 casos** con respecto a la semana anterior y la provincia de Cartago de **112 casos** más.

Tabla 3.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2024

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
Alajuela	7291	674,7	3725	697,4	3566	652,6
San José	6756	395,8	3620	421,5	3136	369,8
Puntarenas	5311	1017,6	2821	1099,8	2490	938,2
Cartago	3285	593,5	1811	656,3	1474	531,1
Limón	1152	240,5	516	221,5	636	258,4
Guanacaste	972	234,1	483	235,9	489	232,3
Heredia	814	147,3	411	149,2	403	145,4
Total	**25581**	**481,8**	**13387**	**507,4**	**12194**	**456,5**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia a la semana epidemiológica 39, 2024.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 39 son: Alajuela 2764 casos, San José 2703 casos, Turrialba 2560 casos, San Carlos 1393 casos y Buenos Aires 1170 casos.

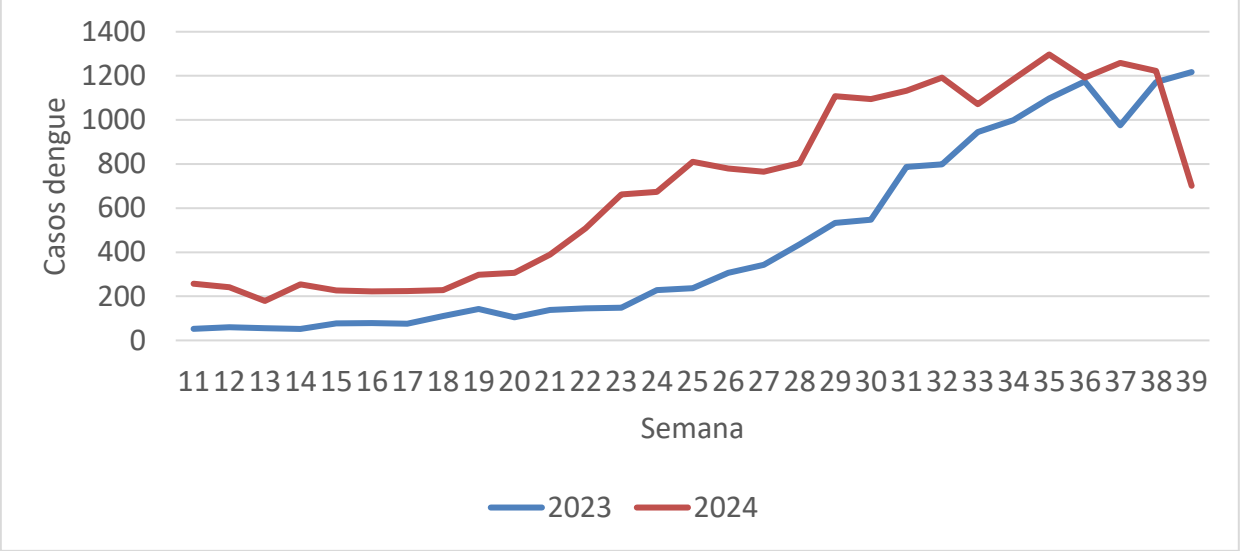
Tabla 4.
Costa Rica: cantones prioritarios en casos de dengue a la semana epidemiológica 39, Costa Rica 2024

Cantón	Casos	Tasa
201: Alajuela	2764	839,7
101: San José	2703	759,2
305: Turrialba	2560	3489,7
210: San Carlos	1393	657,5
603: Buenos Aires	1170	2085,7
205: Atenas	1147	3772,7
109: Santa Ana	1054	1668,4
610: Corredores	1033	1895,0
605: Osa	972	3077,1
103:Desamparados	891	351,9
601: Puntarenas	757	513,2
110: Alajuelita	746	748,8
304: Jiménez	488	2977,1
203: Grecia	382	388,2
209: Orotina	362	1443,5
602: Esparza	325	807,2
207: Palmares	318	745,8
107: Mora	317	1017,4
702: Pococí	313	197,4
604:Montes de Oro	290	1955,2

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

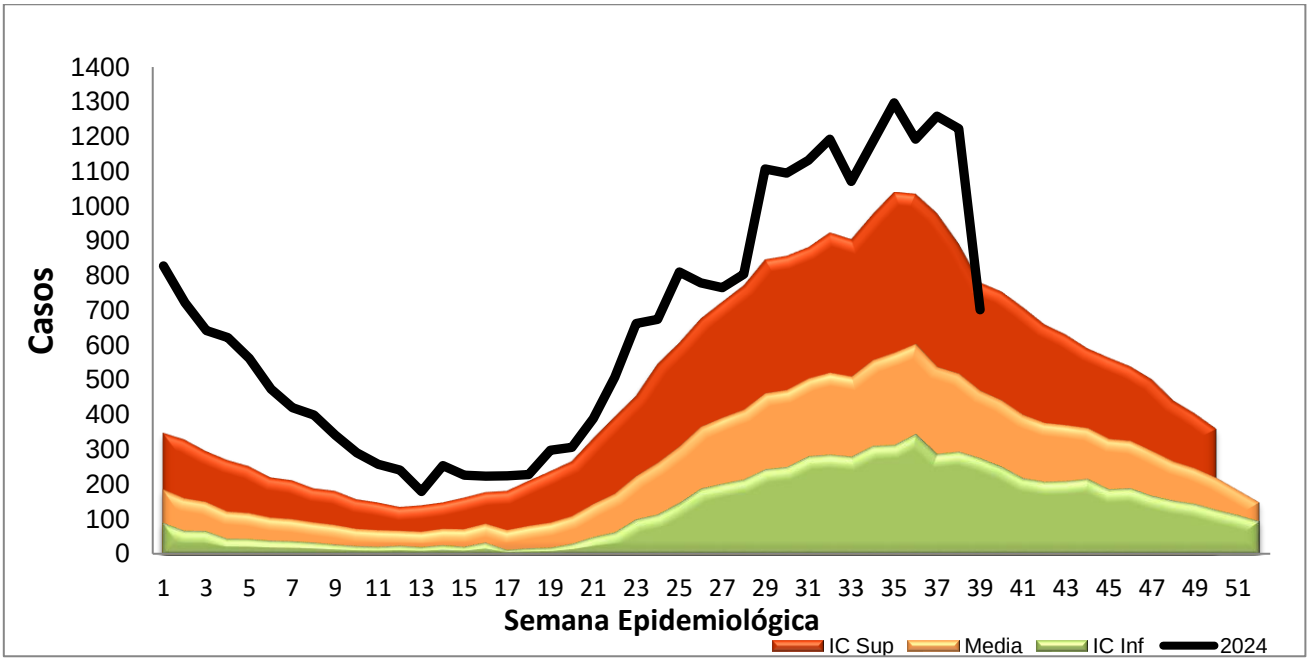
A la semana epidemiológica 39 del 2023 se reportó un total de 13574 casos de dengue, para este 2024 se reportan 25581 para un incremento del 188%.

Figura 3.
Costa Rica: casos de dengue notificados a la semana epidemiológica 39, 2023-2024



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 4.
Costa Rica: Canal endémico dengue, Costa Rica 2024.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Chikungunya

Se registran 37 casos reportados a través de notificación obligatoria por boleta VE01 de chikungunya a la semana epidemiológica 39, ninguno confirmado por PCR.

Tabla 5.
Costa Rica: Casos y tasas de Chikungunya por Región a la semana epidemiológica 39, 2024 (Tasa por 100.000 hab.).

Región	Casos	Tasa
Central Norte	11	1,1
Central Sur	7	0,5
Central Este	5	0,9
Chorotega	4	0,8
Pacífico Central	4	1,2
Brunca	3	0,8
Huetar Norte	2	0,7
Huetar Caribe	1	0,2
Occidente	0	0,0
Total	37	0,7

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Zika

Se registran 20 casos a través de notificación obligatoria por boleta VE01 de zika, a la semana epidemiológica 39, ninguno confirmado por PCR.

Tabla 6.
Costa Rica: Casos y tasas de Zika por Región a la semana epidemiológica 39, 2024 (Tasa por 100.000 hab.).

Región	Casos	Tasa
Chorotega	5	1,1
Central Sur	4	0,3
Pacífico Central	4	1,2
Central Norte	3	0,3
Brunca	1	0,3
Central Este	1	0,2
Huetar Caribe	1	0,2
Huetar Norte	1	0,4
Occidente	0	0,0
Total	20	0,5

Fuente: Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Antecedentes.

En las últimas décadas, Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.

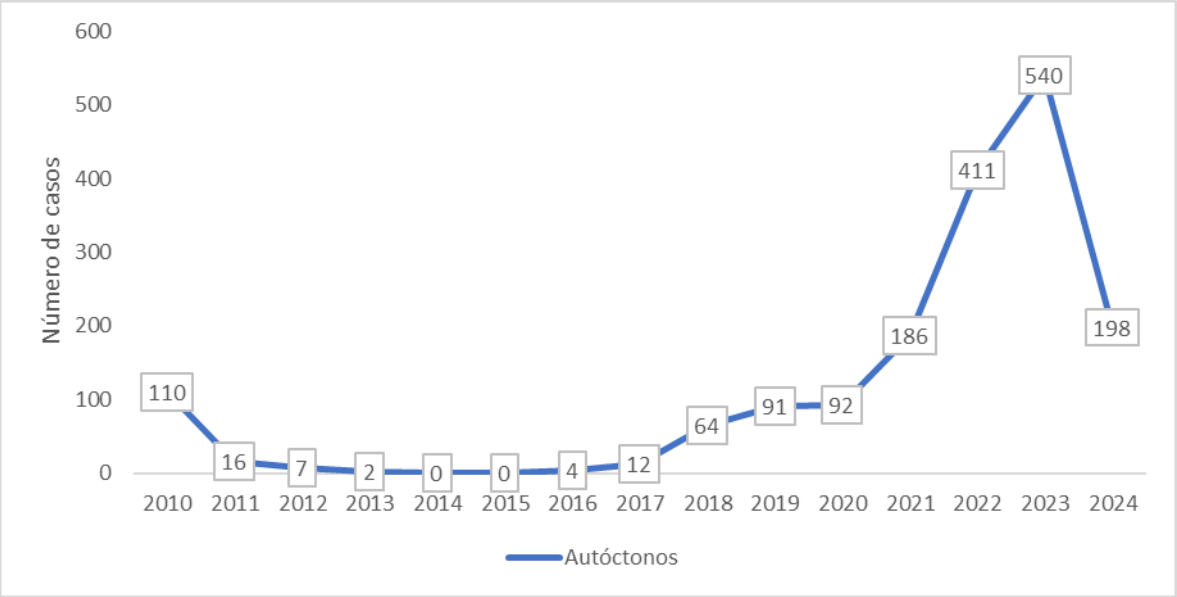
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria. Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.

Costa Rica forma parte de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM) es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

Comportamiento de la malaria en los años 2022, 2023 y 2024

Para el año 2024, como lo muestra la tabla y gráfico 1, se registraron 198 casos autóctonos de malaria. De estos, el 94% (N=186) fueron diagnosticados con *Plasmodium falciparum* y el 6% (N= 12) con *Plasmodium vivax,* incluyendo 4 casos de recaídas. En cuanto a los casos importados, se registran 60 casos, de los cuales el 93% (N= 56) fueron diagnosticados con *P. vivax* y restante corresponde a un caso de *P. falciparum (3%, N=2)*, *P. malariae (2%, N=1),* y *P. ovale (2%, N=1)*. Además, hay 18 casos en estudio, para aun total de 276 casos.

Gráfico 1
Costa Rica: Total de casos autóctonos de Malaria por año, desde 2010 a SE 39, 2024.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos registrados según clasificación epidemiológica y especie parasitaria

Especie Parasitante	Autóctono	Importado	Pendiente	Recaída	Total General
Positivo P. Falciparum	186	2	10	0	198
Positivo P. Malariae	0	1	0	0	1
Positivo P. Ovale	0	1	0	0	1
Positivo P. Vivax	8	56	8	4	76
Total General	194	60	18	4	276

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

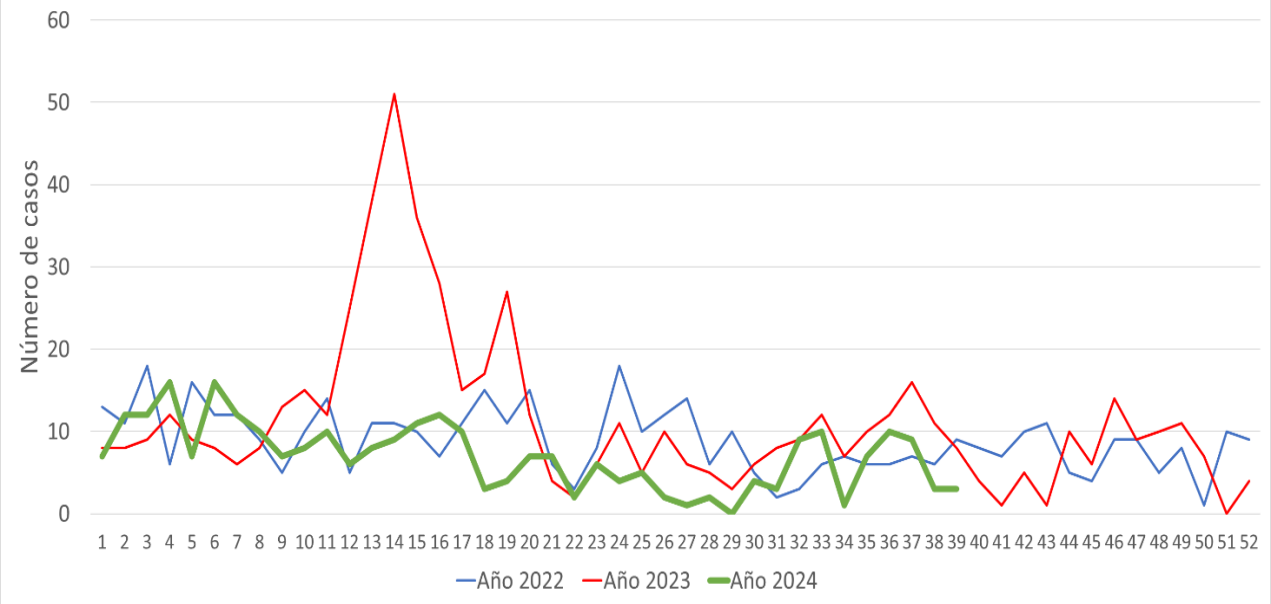
En el año 2022, se registraron un total de 411 casos autóctonos de malaria. En el año siguiente, 2023, se reportaron de manera preliminar 540 casos autóctonos. Por lo tanto, hubo un incremento aproximado del 31% en los casos de malaria del 2022 al 2023.

Se registraron casos en siete regiones, sin embargo, más del 80% de los casos pertenecen a dos regiones Huetar Norte y Huetar Caribe. La región con más casos reportados fue la Huetar Caribe donde se reactivaron dos focos (Limón y Matina) y se intensificó la transmisión en uno de los focos activos (Jardín). Mientras que en la región Huetar Norte, a pesar de ser la segunda región con más casos durante el 2023 detuvo la transmisión local posterior a una administración masiva de medicamentos en la SE 16. En ambas regiones, predominaron los casos por *Plasmodium falciparum.*

Por otro lado, se produjo un brote *por Plasmodium vivax* en la región Brunca, en la frontera sur del país, asociado a la ruta de movilidad humana por Centroamérica.

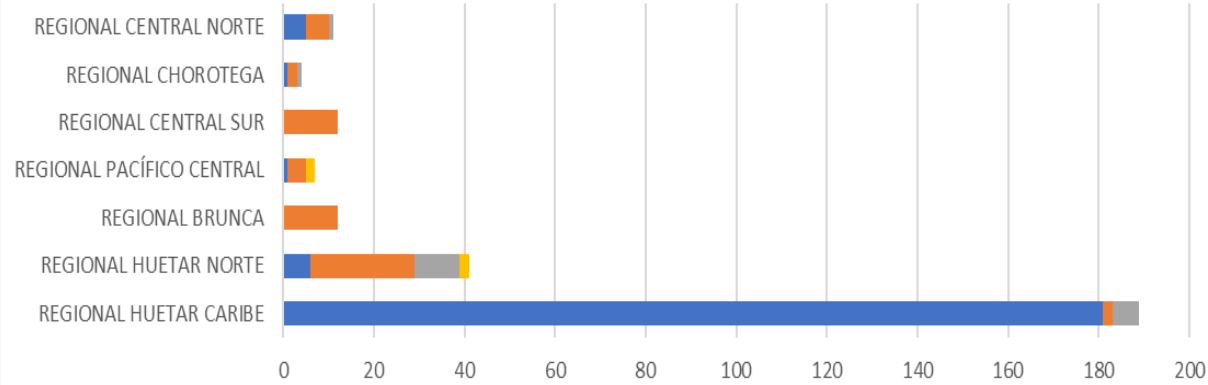
Gráfico 2.

Costa Rica: Comportamiento de casos totales en los años 2022, 2023 y 2024



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos reportados por región según clasificación epidemiológica a semana 39, 2024.



	REGIONAL HUETAR CARIBE	REGIONAL HUETAR NORTE	REGIONAL BRUNCA	REGIONAL PACÍFICO CENTRAL	REGIONAL CENTRAL SUR	REGIONAL CHOROTEGA	REGIONAL CENTRAL NORTE
AUTÓCTONO	181	6	0	1	0	1	5
IMPORTADO	2	23	12	4	12	2	5
PENDIENTE	6	10	0	0	0	1	1
RECAÍDA	0	2	0	2	0	0	0

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

A continuación, se presenta el listado de las comunidades en las que se han detectado casos en las últimas 8 semanas:

Tabla 2.
Costa Rica: Listado de las comunidades en las que se han detectado casos en las últimas 8 semanas.

Cantón	Distrito	Localidad	Total
Limón	**Limón**	Cieneguita	1
Los Chiles	**Los Chiles**	Isla Chica	1
Matina	**Batán**	Ramal Siete	3
		Veintisiete Millas	1
	Carrandi	Desconocido O No Coincide	2
		Estrada	7
		Saborío	3
	Matina	Cuatro Millas	1
		Desconocido O No Coincide	3
		Goli	9
		B Line	1
		Matina	2
San Carlos	**Cutris**	Crucitas	8
		El Roble	2
		Chamorro	1
	Pocosol	Las Tiricias	1
Sarapiquí	**Las Horquetas**	Ticari	1
Siquirres	**Pacuarito**	San Carlos	1
	Siquirres	Betania	1
Puntarenas	**Paquera**	Gigante	1
Santa Ana	**Uruca**	Río Oro	1
Bagaces	**Bagaces**	Agua Caliente	1

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Vigilancia epidemiológica

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos. Las búsquedas activas realizadas por los inspectores de salud del Minsa y pasivas ejecutadas por colaboradores voluntarios y CCSS.

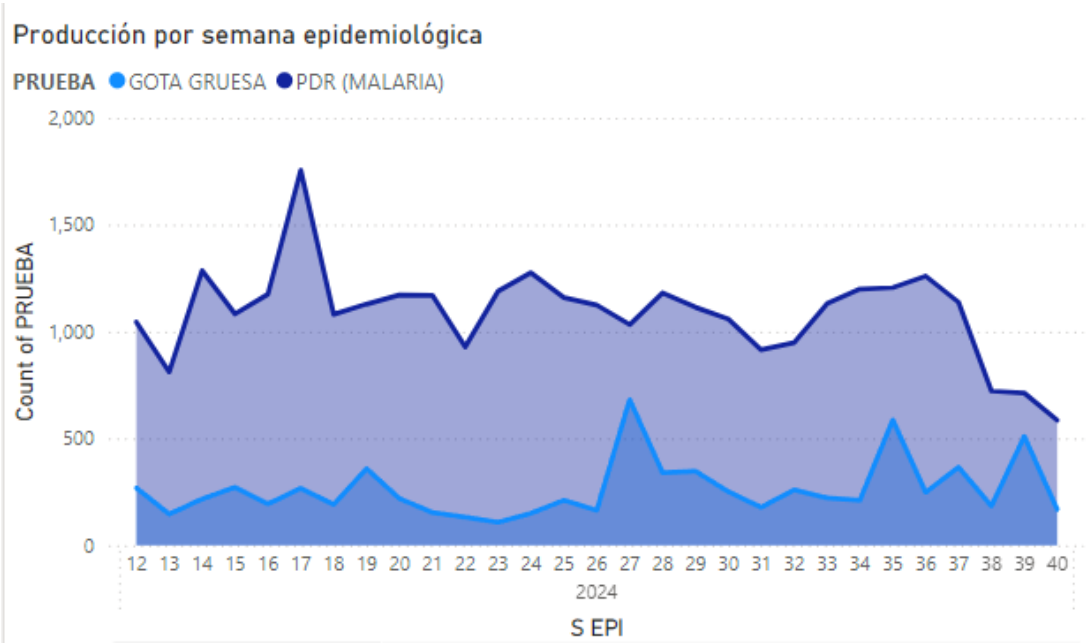
A semana epidemiológica 39, se registraron 38710 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- Gotas gruesas: 8441 (sin considerar muestras de seguimiento)
- Pruebas de diagnóstico rápido: 44865
- Realizadas por CCSS: 31829
- Realizadas por ColVol: 423
- Realizadas por Inspector de salud: 12613

Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.

Nota: Estos datos de producción contemplan únicamente las pruebas de diagnóstico y no de seguimiento. realizadas en el año 2024.

Figura 1.
Costa Rica: Producción de pruebas de diagnóstico de malaria a nivel nacional, consolidado CCSS y Minsa



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica y CCSS.

Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 10 focos activos, 7 focos residuales inactivos y 4 focos eliminados.

Figura 2.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a Enero 2024.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 3.
Costa Rica: Listado de Focos de malaria a Enero 2024, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Activo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Activo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Residual inactivo
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Activo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Activo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Activo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 40

Rodrigo Marín Rodríguez
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud.

Rose Mary Hidalgo Ríos
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud.

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado a la SE_40 del 2024, por el personal de Control de Vectores del país.

Cuadro 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial realizadas a la SE_40 del 2024

Acciones de control vectorial	
	Total
Viviendas visitadas	**559.898**
Viviendas fumigadas	**985.922**
Depósitos tratados	**1.461.985**
Depósitos eliminados	**931.492**

Fuente: Consolidado Nacional de Control de Vectores.

Además, solo en esta semana en la Región Central Este, Región Central Norte y Región Central Sur, del lunes hasta el jueves se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ Casas fumigadas: 17.307.
- ✓ Casas visitadas: 837, en las cuales se realizó educación, aplicación de larvicidas y eliminación de criaderos.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19

Roberto Arroba Tijerino
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Mayra Quesada Sanabria
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

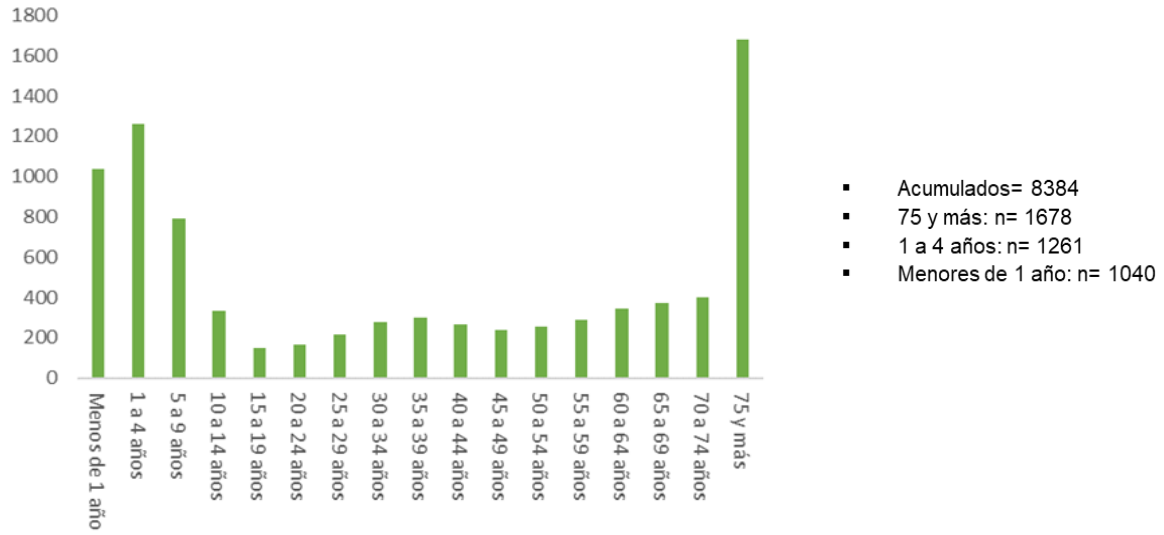
Rafael Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 39 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 39 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 39 son un total de 8384.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños entre 1 y 4 años y en los mayores de 75 años.

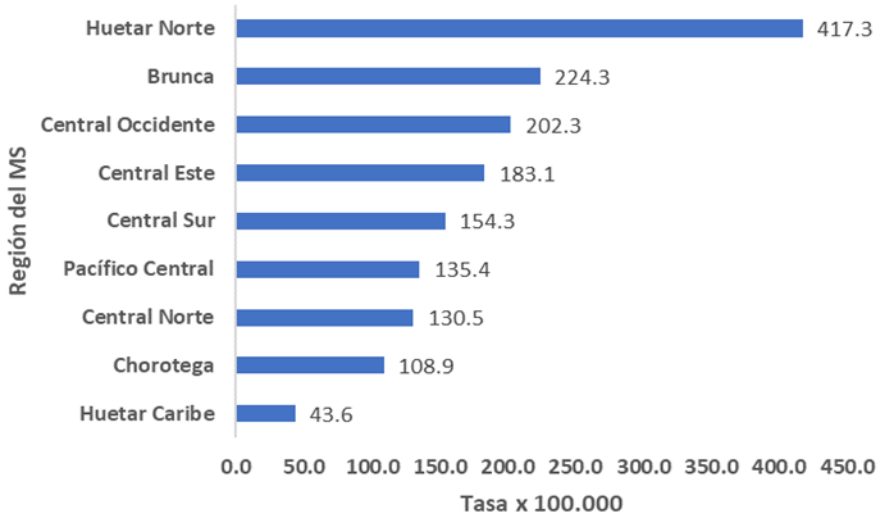
Gráfico 1.
Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 39, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños entre 1 y 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).
En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 39, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Huetar Norte, Brunca, Central Este y Central Occidente; las regiones con menor incidencia corresponden a la Central Sur, Pacífico Central, Central Norte, Chorotega y Huetar Caribe.

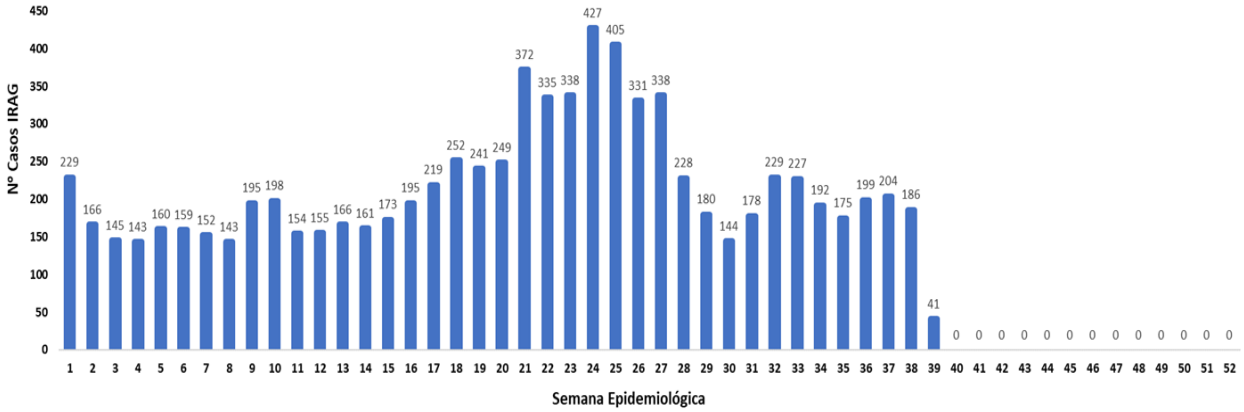
Gráfico 2.
Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 39 del 2024, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 39 del año 2024.

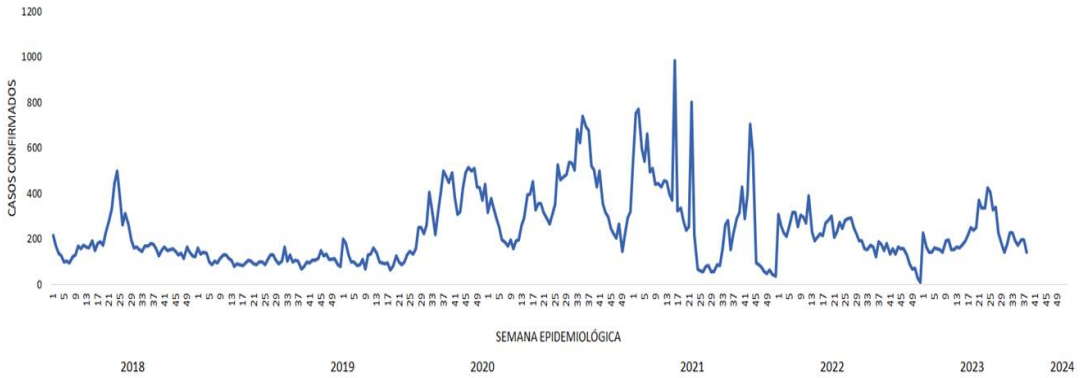
Gráfico 3.
Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 39, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2024, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

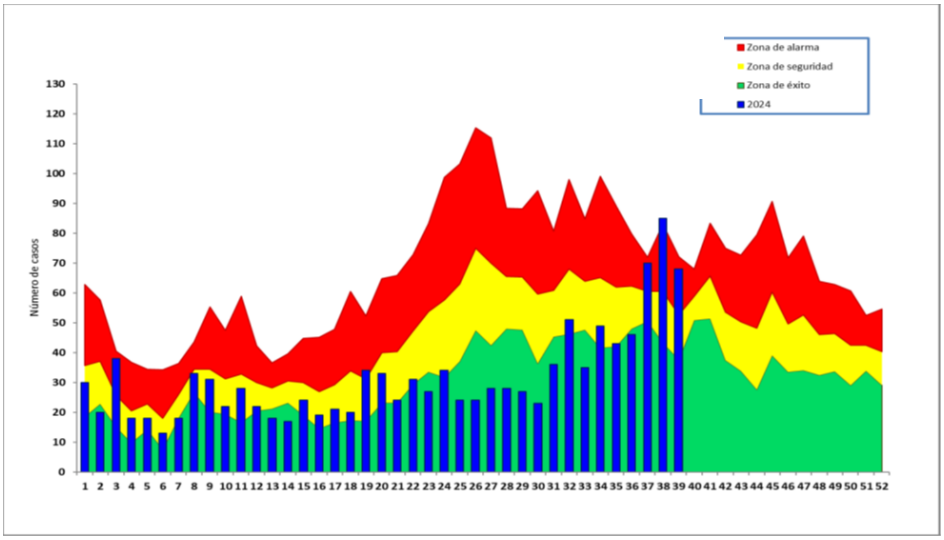
Gráfico 4.
Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

El HNN, para la SE-38 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra en zona de alarma debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

Gráfico 5.
Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2024

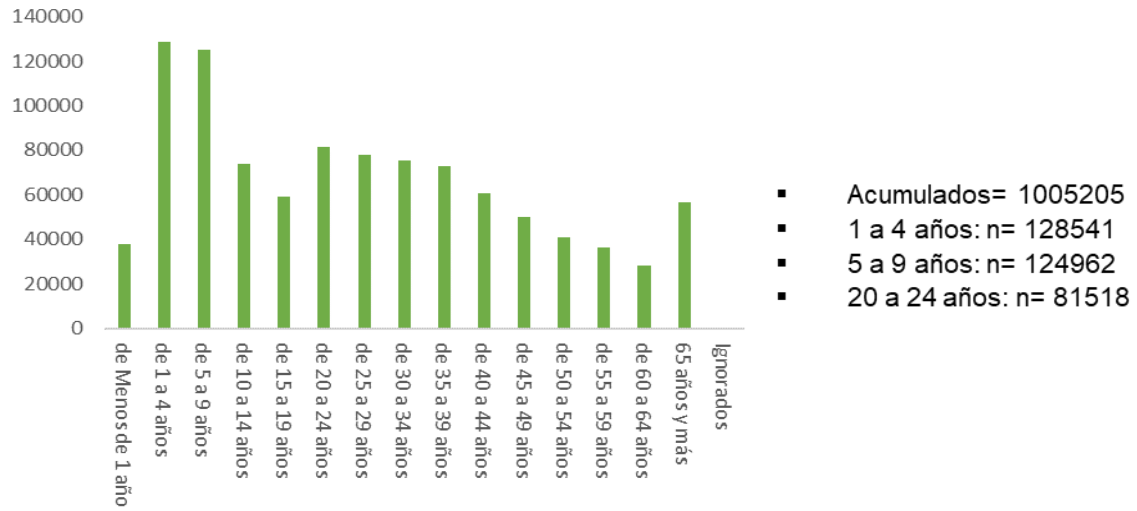


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2024.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 39 son 1005205.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en menores entre 1 y 4 años y niños entre 5 y 9 años.

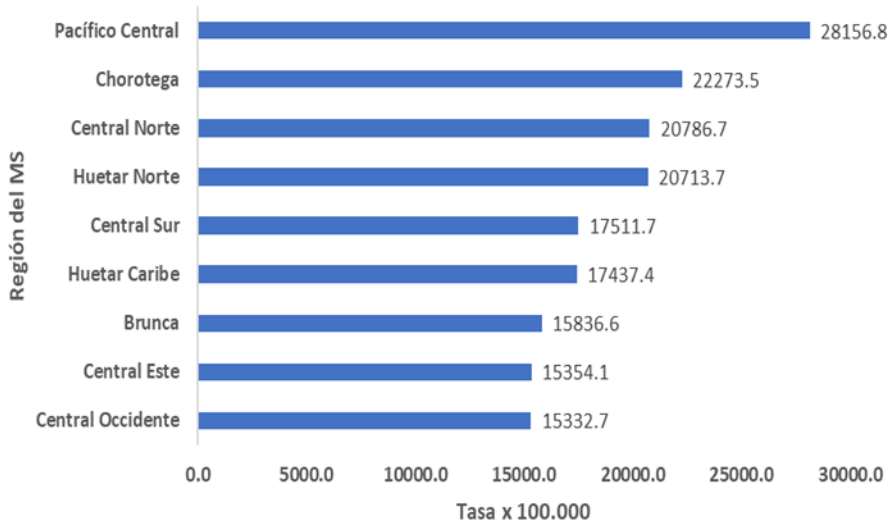
Gráfico 6.
Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 39, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 39, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Pacífico Central, seguido de la Chorotega, la Central Norte, la Huetar Norte, la Central Sur y la Huetar Caribe. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Central Este, la Brunca y la Central Occidente.

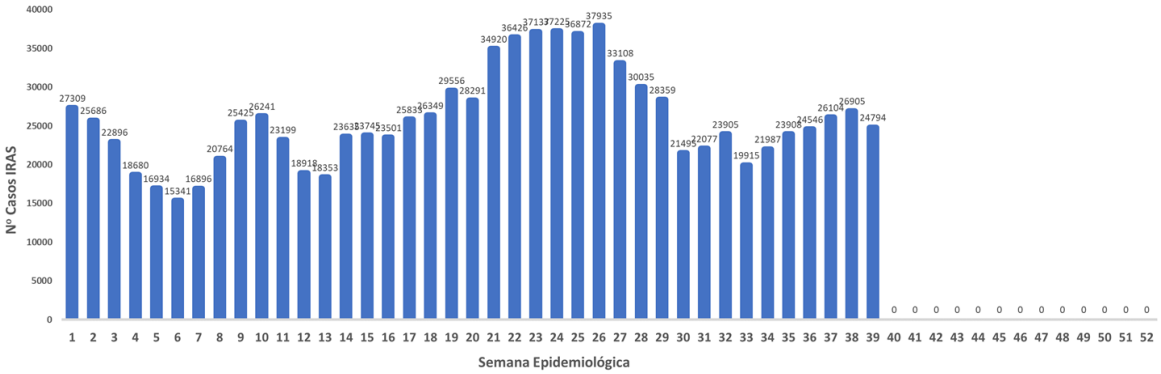
Gráfico 7.
Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 39 del 2024, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado a lo largo de estas 39 semanas epidemiológicas del año 2024.

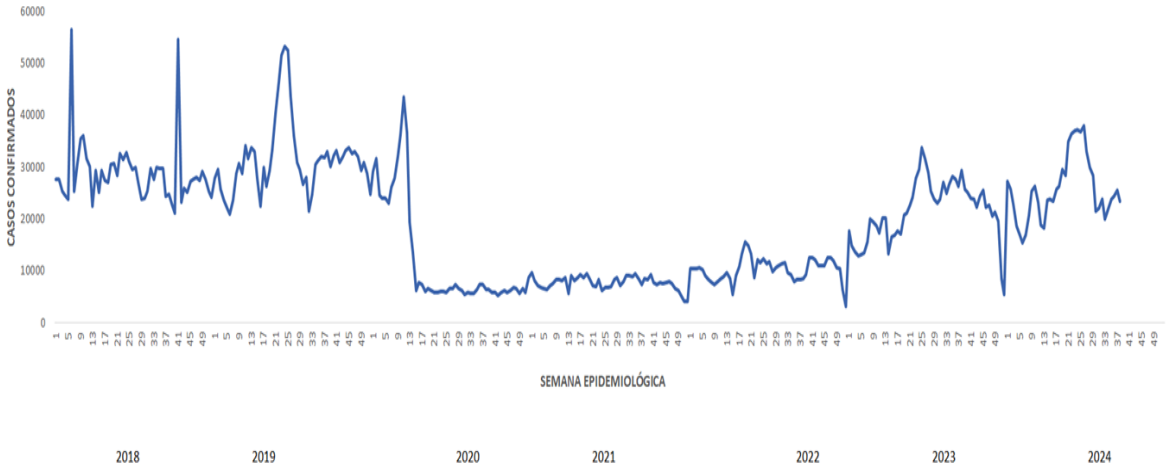
Gráfico 8.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 39, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2024, esto se puede apreciar en el gráfico 9.

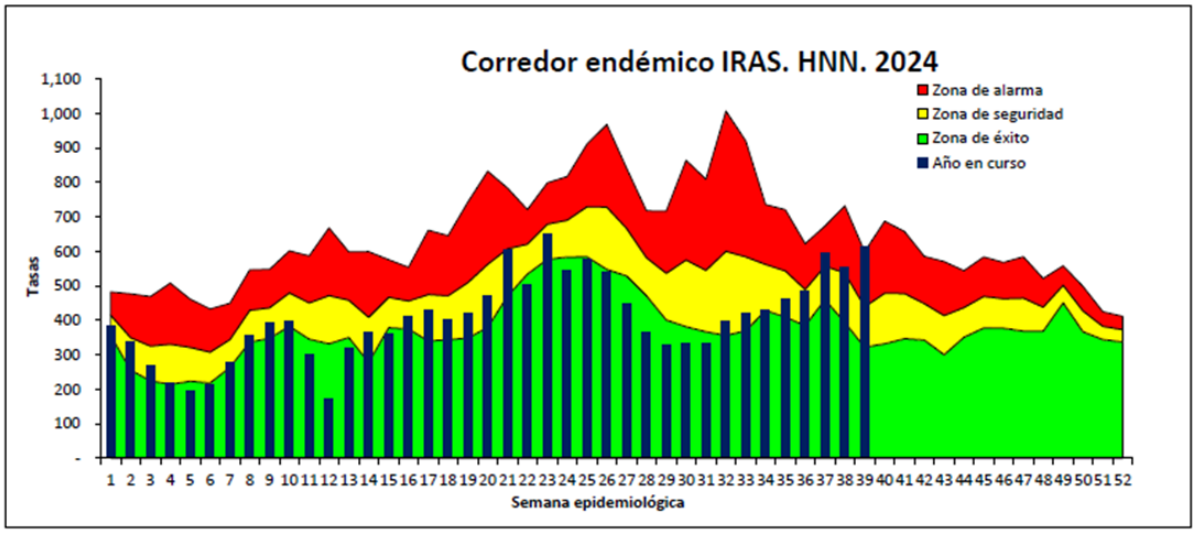
Gráfico 9.
Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 39 se encuentran en zona de alarma.

Gráfico 10.
Costa Rica: Canal endémico IRAS. HNN. 2024.

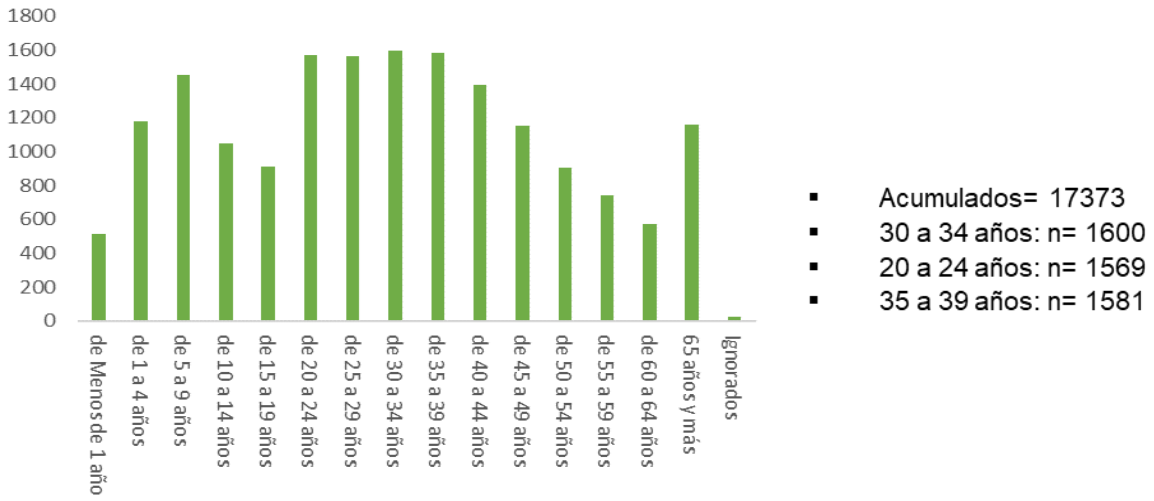


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2024.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 39 son n= 17373.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 30 y 34 años y las personas entre 35 y 39 años.
-

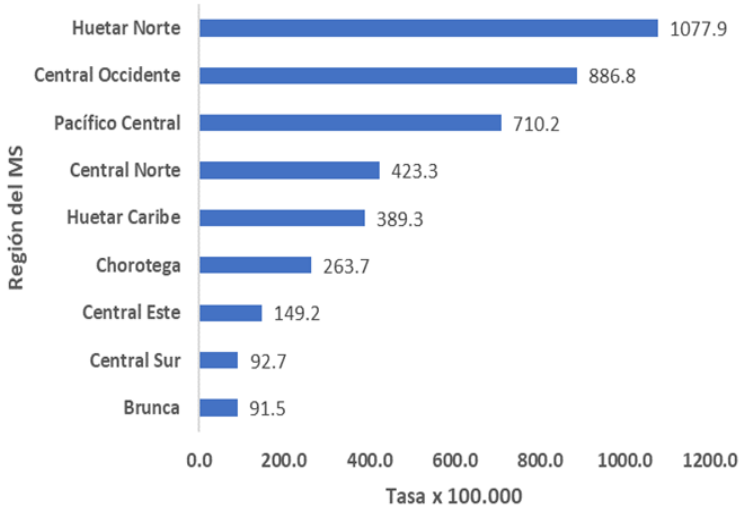
Gráfico 11.
Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 39, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 39, presentando mayor cantidad de casos en la región Huetar Norte, la Pacífico Central, la Central Occidente, Huetar Caribe y la Central Norte. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Chorotega, Central Este, la Brunca y la Central Sur.

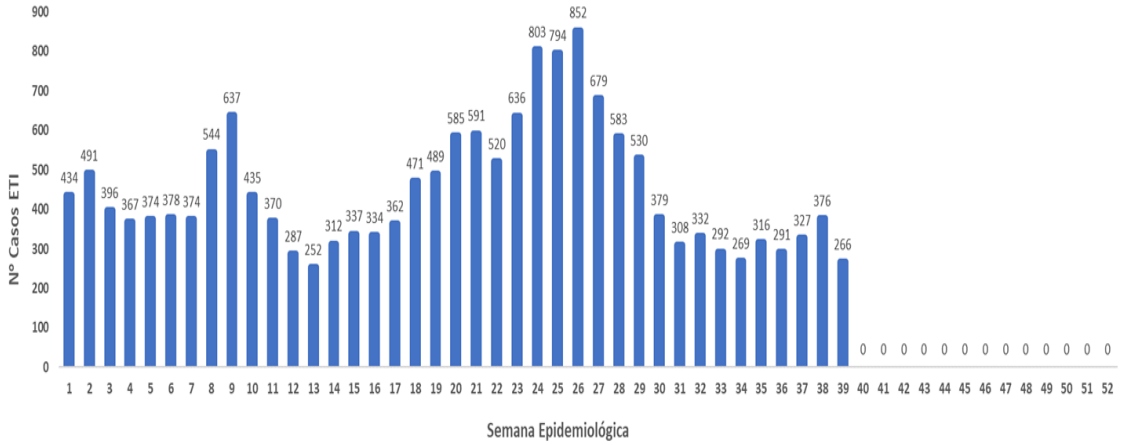
Gráfico 12.
Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 39 del 2024, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2024.

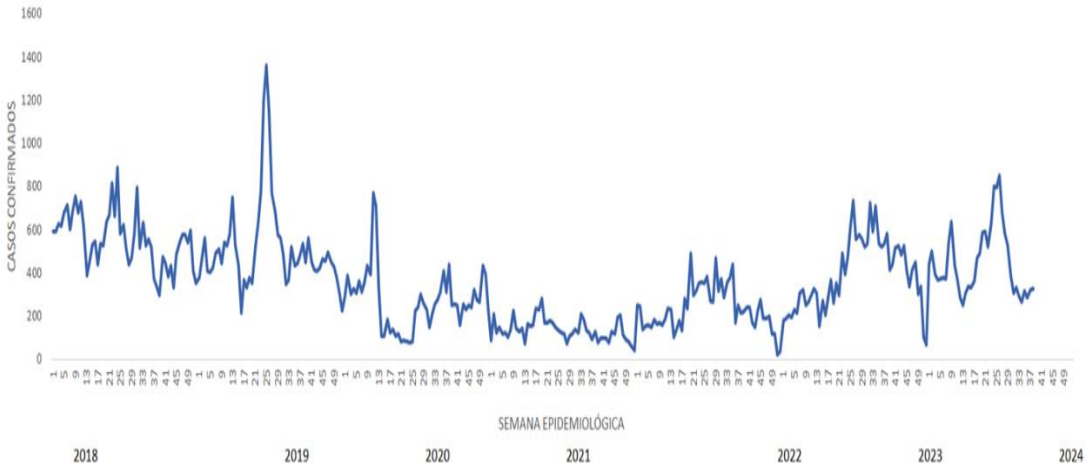
Gráfico 13.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 39, en Costa Rica, 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2024, esto se puede apreciar en el gráfico 14.

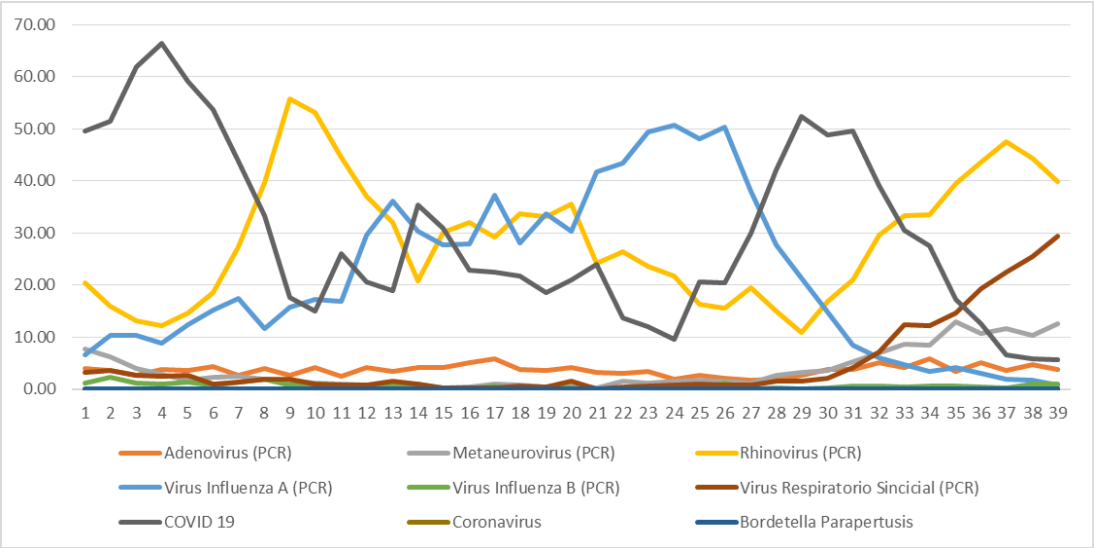
Gráfico 14.
Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2024.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 39; para la SE-39, en el país el Rinovirus es el que más está circulando, seguido del virus sincicial respiratorio, y finalmente, el Metaneumovirus está en tercer lugar de circulación.

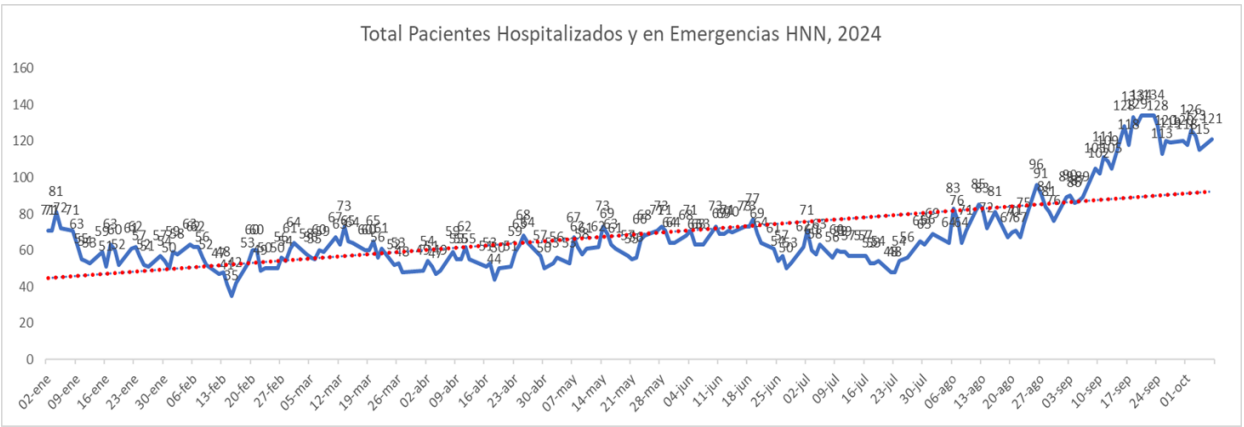
Gráfico 15.
Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 39 en Costa Rica, 2024.



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2024.

En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 41 del año 2024 es la siguiente:
Al 7 de octubre del año en curso, correspondiente a la semana 41, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 106, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 155%.

Gráfico 16.
Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 41 del año 2024, Hospital Nacional de Niños.



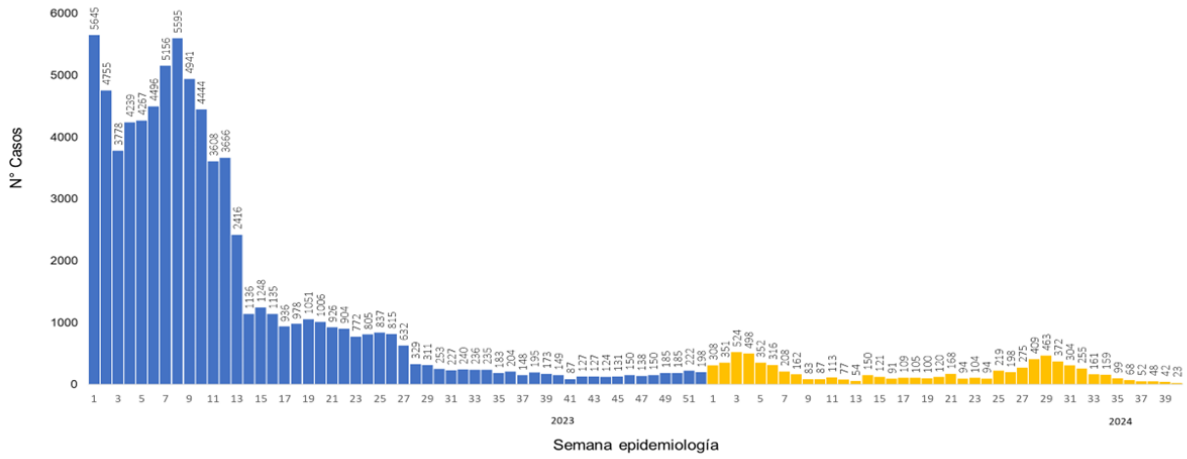
Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2024.

Como observaciones finales se puede indicar lo siguiente:

- IRAG con 8384 casos a la semana 39.
- IRAS con 1005205 casos a la semana 39.
- ETI con 17373 casos reportados a la semana 38.
- Actualmente, la ocupación de camas respiratorias en el HNN es de un 155% (hay 106 pacientes con patologías respiratorias).
- En SE-39, el Rinovirus es el virus que más ha circulado, seguido del virus del virus sincicial respiratorio y en tercer lugar circula el Metaneumovirus.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 40 (que abarca del 29 de setiembre al 5 de octubre del 2024), se reportaron un total de 23 casos confirmados, lo que representa una disminución del 45.23% con respecto a la SE-39 del año 2024.

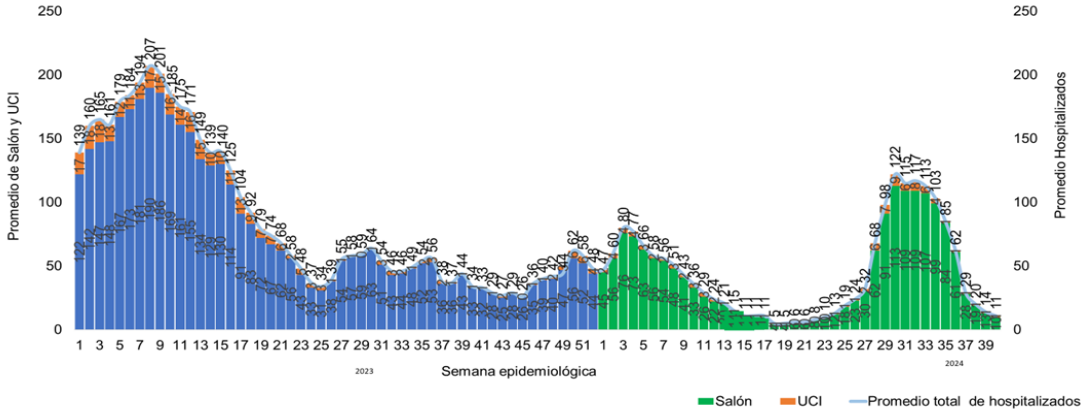
Gráfico 17.
Costa Rica: Casos COVID-19, según semana epidemiológica año 2023-2024.



Datos sujetos para actualizar
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS/Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2024.

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 40, se reportó un promedio total de 11 hospitalizados, lo que representa una disminución del 21.43% en el número de casos hospitalizados con respecto a la SE-39 del año 2024.

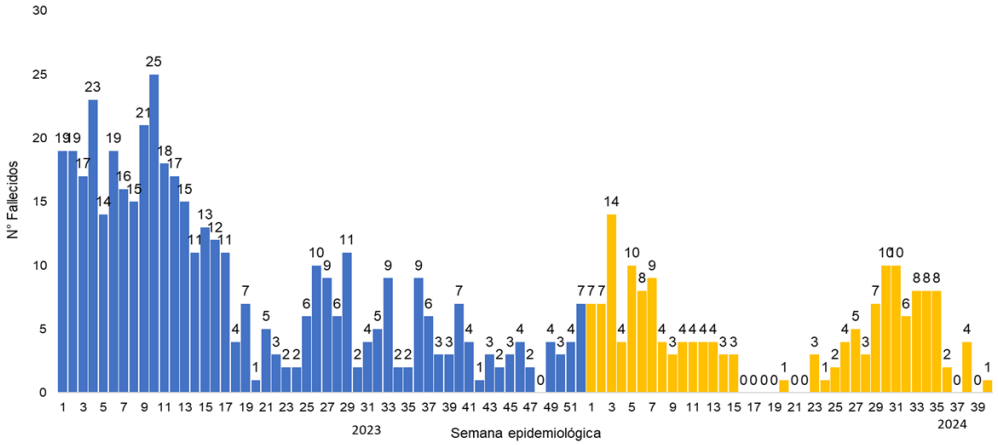
Gráfico 18.
Costa Rica: Promedio total de hospitalizados en salón y Unidad de Cuidados Intensivos, según reporte semanal año 2023-2024.



Fuente: Área de Estadística en Salud, CCSS/Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2023-2024.

En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 40, hubo 1 fallecido; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.

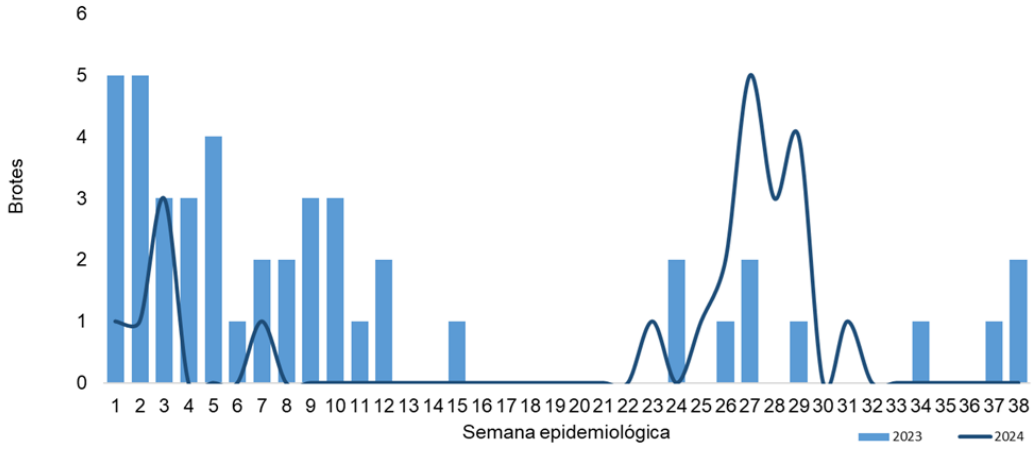
Gráfico 19.
Costa Rica: Personas fallecidas asociadas a COVID-19, según reporte semanal año 2023-2024.



Fuente: Área de Estadística en Salud, C.C.S.S. / Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2024.

Para la semana epidemiológica 40 no se reportaron brotes asociados a COVID-19.

Gráfico 20.
Brotes de covid-19, por semana epidemiológica en Costa Rica, 2024.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, 2024.

En relación con la vacunación contra covid-19, el último reporte de la CCSS muestra la siguiente información.

Gráfico 21.
Coberturas de vacunación contra covid-19, Costa Rica, 2024.

Vacunación COVID 19

2020-2023*

Total de vacunas aplicadas:	1 dosis	2 dosis	3 dosis	4 dosis	5 dosis	Refuerzos
13 602 347	4 652 139	4 371 409	2 989 678	1 240 564	338 687	9 870
	90.1 %	84.7 %	57.9 %	24%	6.6%	

2024**

Total de vacunas aplicadas:	1 dosis	2 dosis	3 dosis (refuerzo)	4 dosis (refuerzo)	Refuerzo
87 407	68 886	1 384	1 056	1 419	10 662
	1.30 %	0.03 %	0.02 %	0.03 %	0.20 %

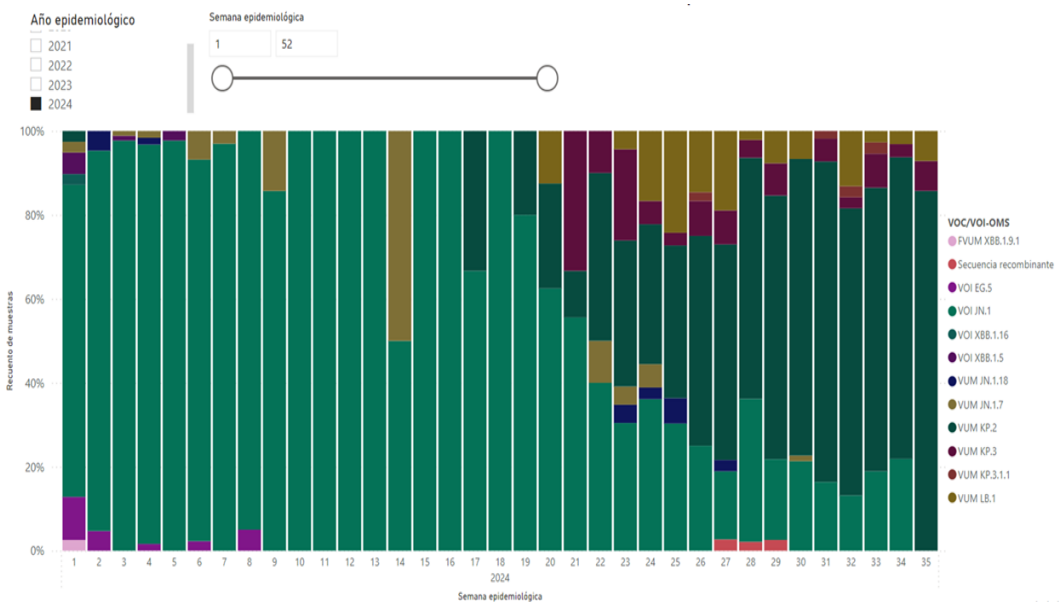
Fuente. SIVA-EDUS. CCSS. Al 2309-2024. SE 38.
**Población Proyecciones Actuarial CCSS 2021 (*) Total de la Población 5,163,021 personas*
***Población Proyecciones Actuarial CCSS 2024 (*) Total de la Población 5,309,625 personas*

Se ha alcanzado una cobertura de vacunación con primeras dosis del 90.1%, con segundas dosis, de un 84.7%, con terceras dosis, la cobertura alcanzada es del 57.9%, y donde hay más rezago es con las cuartas y quintas dosis, con una cobertura alcanzada del 24% y del 6.6%, respectivamente. En relación con los datos de las vacunas contra covid-19 aplicadas en el año 2024 los datos son los siguientes: se han aplicado un total de 87.407 dosis, lo que representa una cobertura del 1.30% con primeras dosis, un 0.03% con segundas dosis, un 0.02% con terceras dosis, un 0.03% con cuartas dosis y un 0.2% con el refuerzo.
Los datos se encuentran actualizados al 23 de setiembre del 2024, según información revisada al 10 de octubre del 2024.

Variantes genómicas

Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 24 de setiembre del 2024, se reporta la circulación del sublinaje de Variante Ómicron (VOC); a la semana 38, se reporta la circulación de la variante bajo vigilancia KP.2, KP.3 y LB.1 (Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, 2024).

Gráfico 22.
Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 1 a 52 del 2024.



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 24 de setiembre del 2024.

En relación con la proporción relativa de sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo comprendido entre las SE-1 y 52 del año 2024, se tiene la siguiente información.

Gráfico 23.
Costa Rica: Proporción relativa de Sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo de las semanas epidemiológicas 1 a 38 del 2024.

Linaje Pangolin	Cantidad	%
LB.1	50	4.93
EG.5	10	0.99
XBB.1.16	1	0.10
JN.1*	539	53.16
XBB.1.5.	4	0.39
XBB.1.9.1	1	0.10
JN.1.7	14	1.38
KP.2	342	33.73
KP.3	36	3.55
KP.3.1.1	4	0.39
Secuencia recombinante	4	0.39
JN.1.18	9	0.89
Total	1014	100.00

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 24 de setiembre 2024.

Bibliografía

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. (2024). Informe Interactivo de Vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2 semana 22. San José: INCIENSA. Obtenido de https://inciensa.sa.cr/Vigilancia%20genomica%20SARS-CoV-2.aspx

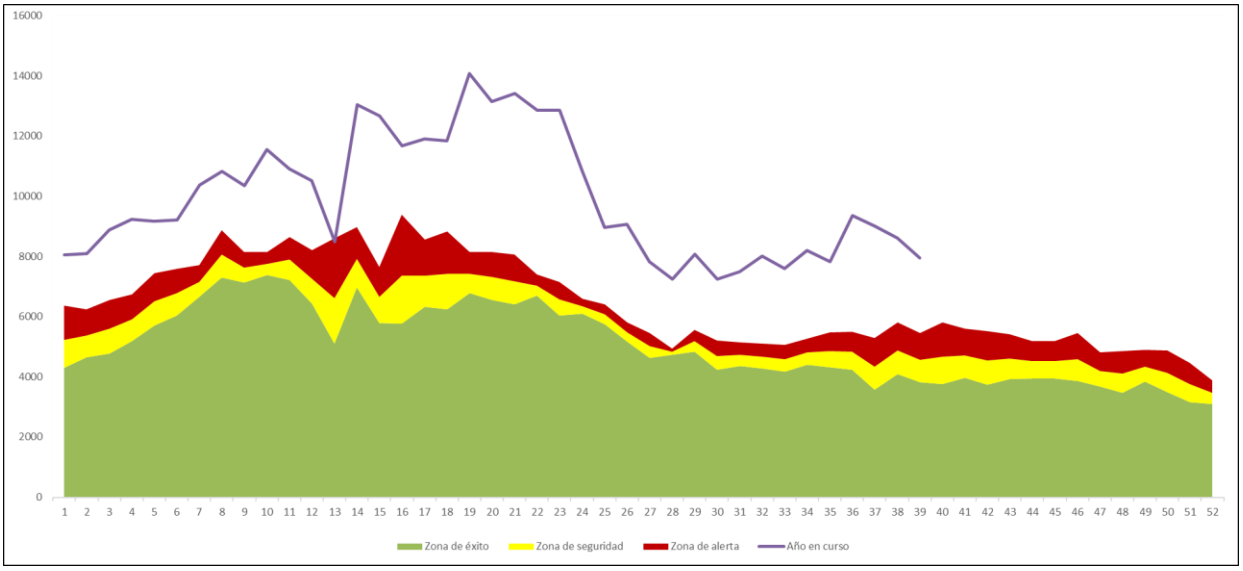
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 7 de octubre 2024.

Ivannia Caravaca Rodríguez.
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

En la semana epidemiológica 39 del 2024 se presentan 386410 casos acumulados de EDA. Según el comportamiento epidemiológico de este evento, se denota una curva epidémica que supera la zona de alerta, con una tasa de 7278 casos de diarrea por cada 100 000 habitantes.

La incidencia de las EDA para la Semana epidemiológica (SE) 39 refleja un aumento significativo en la cantidad de casos notificados en los últimos años, desde el año 2023 el aumento de casos es notorio y es evidente el aumento de las tasas por 100 000 habitantes en todo el territorio nacional. Para la SE 39 se continúa observando una predisposición disminuida en la frecuencia de casos, observándose la misma tendencia de años anteriores.

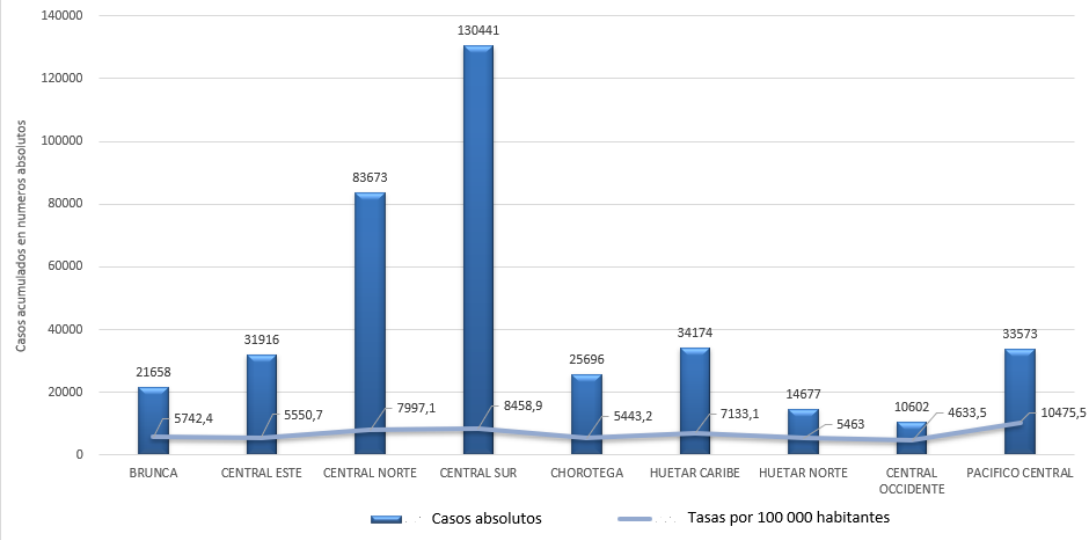
Gráfico 1.
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 39. Años 2015- 2024. (Se excluyen del 2020 al 2022 por pandemia COVID-19)



Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud hasta la SE 39.

La tasa de incidencia más alta por cada 100 000 habitantes se presenta en la Región Pacifico Central (10475 casos por 100 000 habitantes), seguida de la Región Central Sur (8459 casos por 100 000 habitantes), la Región Central Norte (7997 casos por 100 000 habitantes) y la Región Huetar Caribe (7133 casos por 100 000 habitantes). El grupo de edad más afectado es el de adultos de 20 a 39 años.

Gráfico 2.
Costa Rica. Incidencia de casos de EDA, según región del Ministerio de Salud. SE 39, 2024.



Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud hasta la SE 39.

Los cantones con mayores tasas de incidencia de EDA (superiores a 8000 casos por 100 000 habitantes) a la SE 39 son: Montes de Oro, Vázquez de Coronado, Garabito, Orotina, Goicochea, Puntarenas, San Rafael, San José, Cañas, Barva, Alajuelita, Flores, Alajuela, Parrita, Matina, Atenas, Esparza, Heredia, Siquirres, Moravia, Nandayure.

Se recomienda retomar las campañas de educación a la población del Protocolo de Lavado de Manos, las adecuadas prácticas de higiene personal y de cocción y manipulación de alimentos.

El sistema de salud reporta una alta frecuencia de casos de diarreas, ya sean virales o bacterianas, superiores al comportamiento usual, el nuevo Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos dirige el proceso de la investigación adecuada de los casos, así como los flujogramas de trabajo ante diferentes posibles causas, es importante retomar las actividades de vigilancia e investigación ante las alertas.

Miasis por Gusano Barrenador en Humanos

María José Lafuente González
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

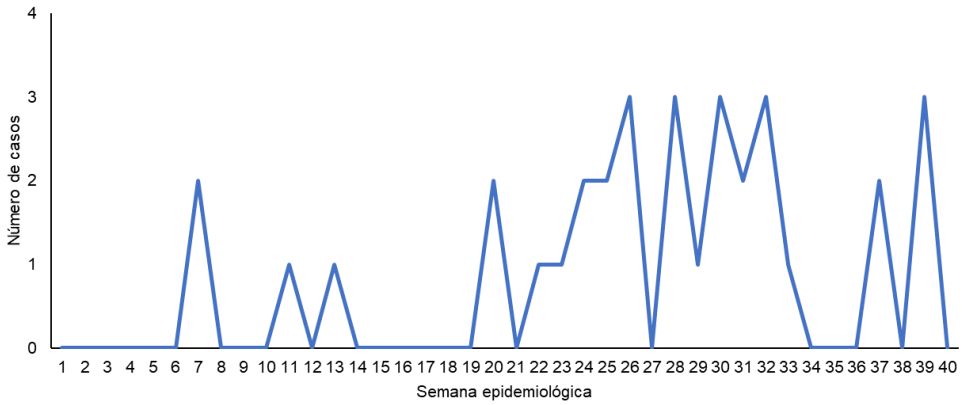
A continuación, se presentan los datos de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica 40; enfermedad de notificación obligatoria al Ministerio de Salud (MS), de acuerdo con lo indicado en el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos.

La Miasis por Gusano Barrenador es una enfermedad parasitaria causada por la fase de larva o gusano de la mosca *Cochliomyia hominivorax*. Afecta a todos los animales de sangre caliente, incluso a los humanos.

En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2024 a la semana epidemiológica 40, se tienen los siguientes datos:

- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 33 casos
- Casos por grupos de edad quinquenal tienen un predominio en las personas adultas de 65 y más años con más casos reportados (n=17)

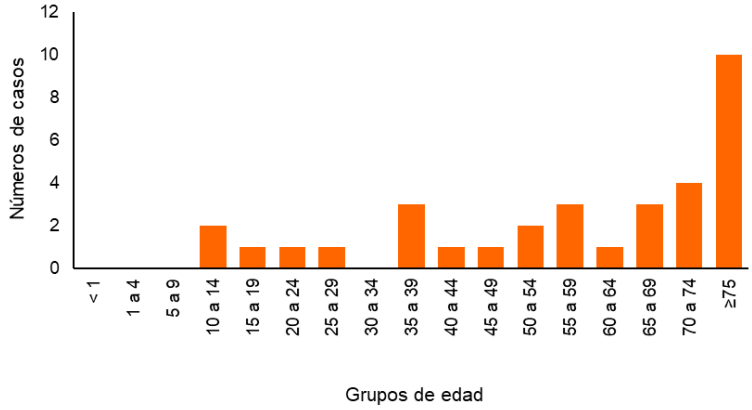
Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, por semana epidemiológica de la 1 a la 40, 2024



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024.

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en estas 40 semanas del año, continua con un predominio en los hombres con 66,67% (n=22) con una tasa de 0,8 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 33,33% (n=11) con una tasa de 0,4 por 100.000 habitantes.

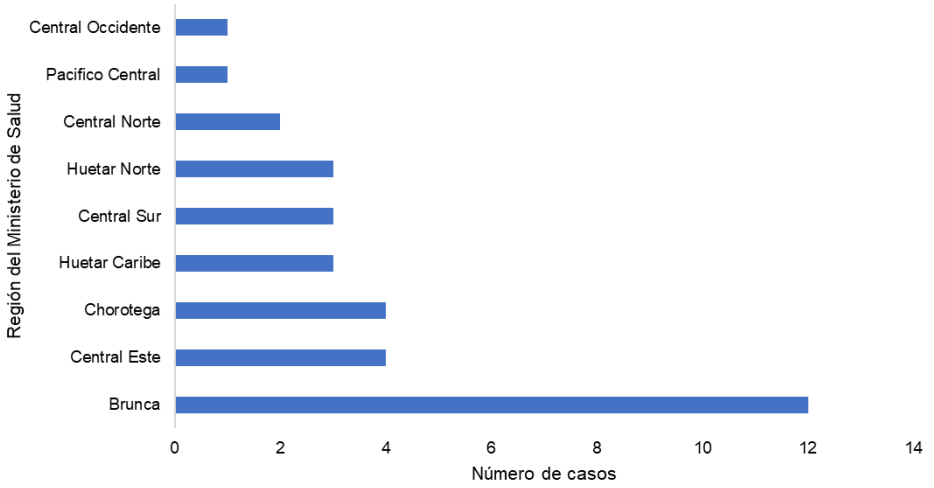
Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por grupos de edad quinquenal, según semana epidemiológica 01 a la 40, 2024



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024.

En el gráfico 2, se muestran los casos por grupos de edad quinquenal observándose un predominio en las personas adultas de 65 y más años con más casos reportados (n=17).

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por región del Ministerio de Salud de procedencia, según semana epidemiológica 01 a la 40, 2024



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024.

En el gráfico 3, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las nueve regiones del país, por número de casos notificados, presentando mayor número de casos en la Región Brunca (n=12) seguido de la Región Central Este y Región Chorotega (n=4).

En el cuadro 1, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por provincia de procedencia, por casos y tasas por 100.000 habitantes notificados a la semana epidemiológica 40, presentando mayor número de casos la provincia de Puntarenas (n=12) seguida por las provincias de San José y Alajuela (n=5) y Guanacaste (n=4).

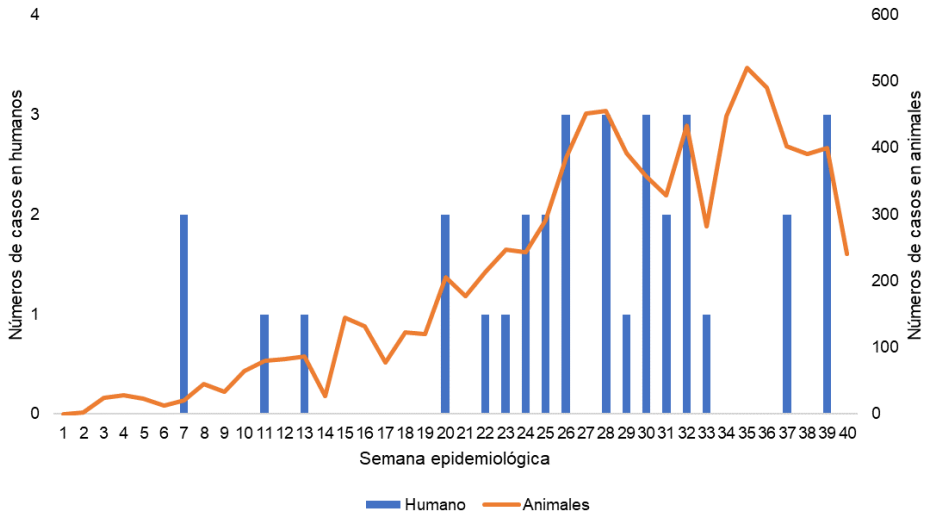
Cuadro 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por provincia de procedencia, por número de casos y tasas (Tasa p/100.000 habitantes), según semana epidemiológica 1 a 40, 2024

Provincias	Casos	Tasas
Total	**33**	**0,6**
San José	5	0,3
Alajuela	5	0,5
Cartago	3	0,5
Heredia	1	0,2
Guanacaste	4	1,0
Puntarenas	12	2,3
Limón	3	0,6

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024.

En el gráfico 4, se muestran los casos de miasis por gusano barrenador en animales y humanos por semana epidemiológica 01 a la 40 del 2024, con 33 casos confirmados en humanos y 8486 casos confirmados en animales.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador en humanos y animales, según semana epidemiológica 01 a la 40, 2024



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Boletín Epidemiológico Extraordinario Gusano Barrenador actualizado al 28 de setiembre del 2024, SENASA / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024.

Es de suma importancia mantener la prevención y control de la miasis por gusano barrenador, dado que la mosca *Cochliomyia hominivorax* continúa circulando en el territorio nacional, por lo que se brinda a continuación las siguientes medidas:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón.
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante.
- Asistir al establecimiento de salud cuando presenta síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la herida.
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA) sobre la aparición de animales de producción o domésticos con gusaneras.